

Амиодарон

Антиаритмик III класса · свойства всех четырёх классов по Вогану — Уильямсу

ФОРМА ВЫПУСКА

5 % · 3 мл = **150 мг**
50 мг/мл

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ

Блокада калиевых каналов фазы 3 → удлинение потенциала действия и рефрактерного периода. Дополнительно: блокада Na⁺-каналов (I), неконкурентная β-блокада (II), блокада Ca²⁺-каналов (IV). Вазодилатация (в т.ч. от полисорбата 80). T½ 40-55 суток.

ДОЗИРОВАНИЕ ПО АЛГОРИТМАМ

Клиническая ситуация	Доза	Путь
ФЖ / ЖТ без пульса (после 3-го разряда)	300 мг (6 мл)	в/в струйно
Повторно при сохраняющейся аритмии	150 мг (3 мл)	в/в однократно
Стабильная ширококомплексная тахикардия	150-300 мг в декстрозе 5 % до 20 мл	в/в струйно
ФП < 48 ч (при противопоказаниях к пропафенону)	5 мг/кг (макс. 450 мг) в 250 мл декстрозы 5 %	в/в кап.
Дети: тахисистолия / WPW	5 мг/кг (0,1 мл/кг)	в/в кап. ≥ 30 мин
Пируэтная тахикардия (torsades de pointes)	противопоказан → магния сульфат	

Растворитель: только декстроза 5 %. NaCl 0,9 % — осадок. Концентрация ≥ 0,6 мг/мл. Инфузия через насос (полисорбат искажает каплю).

НАСОС 31-Р дети: 150 мг (3 мл) + 47 мл декстрозы 5 % = 50 мл (3 мг/мл); ступени 5, 10, 15 мкг/кг/мин

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ

- Пируэтная тахикардия — сам удлиняет QT
- Сочетание с β-блокаторами, верапамилом → тяжёлая брадикардия, АВ-блокада, гипотензия
- Препараты, удлиняющие QT (макролиды, антипсихотики) → torsades de pointes
- Новорождённые: бензиловый спирт → «gasping syndrome»

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ТАКТИКА

- Болюс вне остановки сердца → риск тяжёлой гипотензии; вне СЛР вводить за 20 мин
- Дигоксин: концентрация растёт вдвое; варфарин: рост МНО
- Пациент, отменивший амиодарон месяц назад, всё ещё под действием (T½ до 100 суток)
- Линию промывать декстрозой 5 %; не смешивать в одном шприце